CODICE 6 — DELLA SALUTE

Versione: V1.5
Allineamento dichiarato: Costituzione V.29; Codice 1 V1.6; Codice 2 V1.5; Codice 3 V1.5; Codice 4 V1.4; Codice 5 V1.4; Codice 7 V1.7; Codice 8 V1.4; C.1-Annex A V1.4; Codice 9 V3.1; Codice 10 V1.4; Codice 11 V1.3; Codice 12 V1.3; Codice 13 V1.4; Codice 14 V1.2; Codice 15 V1.4; Codice 16 V1.4.

TITOLO PRELIMINARE — PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 — Oggetto e natura giuridica

1. Il presente Codice disciplina la tutela della salute quale bene comune infrastrutturale, diritto inviolabile e condizione materiale di esistenza della Confederazione, secondo l'articolo 1.2 della Costituzione.
2. La salute non è una merce, una prestazione a pagamento o un privilegio collegato al possesso di competenze o alla quantità di CBO svolta.
3. Ai fini del presente Codice, per salute si intende il benessere fisico, psichico, relazionale e ambientale della persona. La sua valutazione rispetta l'autodeterminazione individuale e considera le condizioni collettive che incidono sulla salute.
4. Il presente Codice disciplina:
    a) la prevenzione dei rischi connessi al CBO, ai Magazzini e agli habitat;
    b) la sorveglianza sanitaria e il coordinamento con la sicurezza delle mansioni;
    c) la cura primaria, la cura delle persone fragili e la salute mentale;
    d) la gestione degli infortuni e delle malattie professionali;
    e) il Paniere Salute e l'autonomia farmaceutica;
    f) la riservatezza dei dati sanitari.
5. Le competenze del presente Codice si coordinano con quelle dei Codici 12 e 14. Il Consiglio Salute non sostituisce gli organi competenti in materia di sicurezza generale, cura delle persone fragili o protezione dei dati.

Art. 2 — Principi

1. **Prevenzione.** Le attività di CBO, produzione, logistica e apprendimento sono organizzate in modo da prevenire i danni alla salute prima che si verifichino.
2. **Autodeterminazione.** Ogni persona decide sul proprio corpo e sul proprio percorso di cura sulla base di un consenso libero, informato e revocabile, salvo le misure eccezionali previste dall'articolo 2-bis e nei limiti ivi stabiliti.
3. **Non colpevolizzazione.** Malattia, infortunio e fragilità non costituiscono colpa e non possono comportare, per sé, riduzione del Paniere di Sufficienza, esclusione o sanzione. Si applicano le garanzie del Codice 4.
4. **Prossimità.** La cura è organizzata, per quanto possibile, nel Cerchio, nel Magazzino e nell'habitat della persona. Il ricorso a servizi ospedalieri o centralizzati è disposto quando sia necessario per accedere a competenze di Livello 3 non disponibili localmente.
5. **Non mercificazione del sapere.** È vietato brevettare o assoggettare a paywall il sapere salvavita e la conoscenza sanitaria essenziale. È vietata la rendita derivante dal monopolio di competenze sanitarie, secondo il Codice 5, articolo 8.
6. **Proporzionalità e riservatezza.** Ogni misura sanitaria è limitata allo scopo per cui è adottata. Le informazioni sanitarie sono trattate solo nella misura necessaria e con le garanzie dell'articolo 11.

Art. 2-bis — Rischio collettivo immediato e coordinamento con l’articolo 8

1. Per **rischio collettivo immediato e documentato** si intende una situazione in cui un agente patogeno, un contaminante o una condizione ambientale, sulla base di evidenze scientifiche verificabili e registrate nel Magazzino del Sapere Salute, comporta un pericolo concreto, attuale e grave di diffusione o danno a terzi, non evitabile con misure meno invasive.
2. L’accertamento è avviato su proposta del Consiglio Salute e richiede:

   a) un dossier che descriva le evidenze, il rischio, le persone o i gruppi potenzialmente esposti e le alternative considerate;

   b) il parere di almeno due persone con competenza di Livello 3, indipendenti e non appartenenti al Cerchio proponente;

   c) la validazione della STV applicabile, quando prevista.
3. Le misure collettive sono deliberate dall’Assemblea Generale secondo la procedura d’urgenza del Codice 3. La deliberazione è motivata e documenta necessità, proporzionalità, durata, alternative meno invasive e criteri di cessazione. Il coordinamento con il Codice 14 si applica quando siano coinvolti profili di sicurezza generale o di interruzione di attività.
4. La misura:

   a) dura al massimo trenta giorni;

   b) può essere rinnovata solo con una nuova deliberazione e nuova documentazione;

   c) è limitata a quanto strettamente necessario e adotta la misura meno invasiva idonea;

   d) è riesaminata dal Cerchio di Garanzia, su richiesta di qualsiasi membro, entro sette giorni;

   e) è registrata con motivazione, durata e criteri di cessazione, nel rispetto della riservatezza e dei livelli di accesso previsti dai Codici.
5. Quando vengono meno i presupposti, la misura cessa immediatamente. Il rinnovo non può fondarsi sulla sola inerzia o sulla mancata conclusione di un riesame.
6. Il presente articolo disciplina misure di salute pubblica rivolte alla collettività. L’articolo 8 disciplina gli interventi individuali di emergenza sanitaria riguardanti una persona in crisi. I due regimi hanno oggetto, presupposti e procedure distinti e non si cumulano, salvo che siano documentate entrambe le condizioni.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non possono produrre effetti permanenti sull’accesso al CBO, al Paniere, alla partecipazione deliberativa o agli altri diritti. Eventuali effetti ulteriori richiedono una procedura autonoma prevista dai Codici competenti e le relative garanzie.
8. Alla cessazione della misura è ripristinata la posizione giuridica precedente della persona. Gli atti necessari a documentare, verificare o sottoporre ad audit la misura possono essere conservati, con accesso limitato e secondo le garanzie di riservatezza dell’articolo 11.

CAPO I — ORGANIZZAZIONE, SCHEDE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Art. 3 — Consiglio Salute

1. Ogni Cerchio 1 istituisce un Consiglio Salute composto da tre a sette membri, con competenze di Livello 2 o 3 in ambito sanitario, di cura, agroecologico o di sicurezza sul lavoro. È l’articolazione locale del Cerchio di Competenza Medicina e Salute. I componenti sono sorteggiati secondo l’articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio prima di dodici mesi dalla fine del mandato.
2. Il Consiglio Salute:

   a) gestisce il Magazzino Salute e il Paniere Salute di cui all’articolo 10;

b) redige e aggiorna, per i profili sanitari di propria competenza, le Schede di Sicurezza delle mansioni CBO;

c) organizza la sorveglianza sanitaria, la gestione dei DPI di competenza sanitaria e la formazione L1 sulla salute;

d) registra e analizza infortuni, quasi-infortuni e malattie professionali;

e) coordina la cura delle persone fragili e gli interventi di salute mentale secondo il Codice 12;

f) coordina con gli altri Cerchi 1 la gestione delle competenze scarse e delle emergenze vitali, secondo l'articolo 32 del Codice 1 e il Codice 14.

3. Il Consiglio Salute non dispone di poteri allocativi sui beni né di poteri disciplinari. Non può negare o condizionare l'accesso al Paniere.

4. Il Consiglio formula proposte, documenta i rischi sanitari, organizza l'assistenza e svolge le funzioni attribuitegli dal presente Codice. Le sue decisioni sono adottate secondo il metodo del consenso previsto dal Codice 3 e sono tracciate.

5. Per ogni mansione CBO è individuato un referente per la sicurezza con competenza L2, validata secondo il Codice 5. Il referente non sostituisce il Consiglio Salute né il Consiglio Sicurezza previsto dal Codice 14.

Art. 4 — Schede di Sicurezza, DPI e coordinamento con il Codice 2

1. Nessuna attività CBO può essere svolta senza una Scheda di Sicurezza vigente, predisposta secondo le STV applicabili e coordinata con i Codici 1 e 14.

2. Quando una mansione presenta profili sanitari e di sicurezza generale, la Scheda può essere unica e integrata oppure composta da documenti collegati con lo stesso identificativo e la stessa versione. Il Consiglio Salute valida i profili sanitari; il Consiglio Sicurezza valida i profili di sicurezza generale; il Consiglio di Magazzino valida gli aspetti organizzativi di propria competenza. Nessun Consiglio può modificare i parametri attribuiti agli altri.

3. La Scheda contiene almeno:

   a) i rischi specifici;

   b) i DPI e le protezioni collettive necessari;

   c) le procedure operative;

   d) gli errori tipici e le misure per prevenirli;

   e) le condizioni di sospensione;

   f) i riferimenti alle STV applicabili;

   g) i limiti di esposizione e le pause richieste;

   h) la formazione minima necessaria;

   i) la data, la versione, i responsabili e le condizioni di revisione.

4. I DPI sono beni comuni e sono forniti gratuitamente. Sono accessibili, mantenuti efficienti e tracciati dai soggetti competenti per custodia e approvvigionamento. L'assenza di un DPI critico previsto dalla Scheda comporta l'immediata sospensione dell'attività interessata e non costituisce una violazione imputabile alla persona cui il DPI non è stato fornito. L'obbligo di predisporre i DPI spetta al Cerchio responsabile dell'attività.

5. Ogni membro può interrompere un'attività quando rilevi un rischio grave e immediato per sé o per altri. L'interruzione è comunicata appena possibile al responsabile operativo e al Consiglio competente; non può comportare ritorsioni se effettuata in buona fede. Si applicano il Codice 14 e, per la continuità logistica, l'articolo 32, comma 3, del Codice 1.

6. La STV di un bene include i profili di sicurezza sanitaria relativi a produzione, uso, manutenzione e smaltimento. La STV è coordinata con la Scheda di Sicurezza e non la sostituisce quando quest'ultima è richiesta per una specifica mansione.

Art. 5 — Sorveglianza sanitaria, volontarietà e condizioni di sicurezza

1. La sorveglianza sanitaria è volontaria come percorso generale di cura e prevenzione. Per le mansioni individuate ai sensi del comma 2, una valutazione di idoneità può costituire un requisito tecnico per lo svolgimento autonomo di quella specifica mansione; non costituisce un obbligo sanitario generale.
2. Si applicano le seguenti regole:

   a) per le attività CBO a rischio nullo o basso non è richiesta una visita obbligatoria;

   b) per le attività a rischio medio o alto, classificate secondo le STV e la Scheda di Sicurezza, la valutazione di idoneità è richiesta solo quando sia necessaria per la sicurezza della mansione autonoma;

   c) la valutazione di idoneità non è condizione per accedere al Paniere, partecipare alle deliberazioni o appartenere alla Comunità;

   d) chi rifiuta la visita necessaria per una mansione a rischio medio o alto non svolge autonomamente quella specifica mansione, ma conserva il Paniere di Sufficienza, l'accesso agli altri CBO compatibili e il diritto a una mansione alternativa adattata. Il rifiuto non costituisce infrazione e non è registrato come annotazione pregiudizievole;

   e) la visita periodica prevista per una competenza sanitaria L3 ad alto rischio può essere condizione per mantenere la relativa validazione, secondo l'articolo 4, comma 5, del Codice 5. Il rifiuto comporta, se necessario, la sospensione della specifica validazione, non una sanzione.
3. Le valutazioni sanitarie possono comprendere:

   a) una visita iniziale per le mansioni a rischio medio o alto, quando necessaria ai sensi del comma 2;

   b) una visita periodica per le competenze L3, almeno biennale o annuale in caso di esposizione continuativa, secondo le STV applicabili;

   c) una visita richiesta dalla persona in qualsiasi momento;

   d) una visita successiva a un infortunio o a una malattia professionale.
4. Il giudizio è descrittivo e limitato alla mansione interessata. Può indicare:

   a) idoneità;

   b) idoneità con adattamenti;

   c) idoneità con limitazioni temporanee;

   d) sospensione temporanea precauzionale dalla mansione, con mantenimento del Paniere e proposta di un CBO alternativo.
5. L'inidoneità definitiva a una specifica mansione può essere pronunciata esclusivamente da un Collegio di Riesame esterno secondo le garanzie del Codice 4, articolo 17. Il Collegio è composto da:

   a) una persona con competenza sanitaria L3, sorteggiata e non appartenente al Cerchio della persona interessata;

   b) una persona del Consiglio Qualità non coinvolta nel procedimento;

   c) una persona sorteggiata tra i membri dell'Assemblea di un Cerchio 1 diverso da quello interessato, con funzione di garanzia procedurale.
6. Prima della decisione, il Collegio acquisisce il parere scritto di due persone con competenza sanitaria L3 indipendenti, non coinvolte nei precedenti giudizi e, ove pertinente, con specializzazioni diverse. Le persone che esprimono il parere non fanno parte del Collegio e non partecipano alla decisione.
7. Nessun componente del Collegio può avere espresso un precedente giudizio di idoneità sulla medesima persona e mansione. I pareri sono messi a disposizione della persona interessata prima della decisione, salvo le limitazioni strettamente necessarie per proteggere dati sanitari di terzi.
8. La decisione è motivata e tracciata. Contro l'inidoneità definitiva è ammesso ricorso entro quattordici giorni a un nuovo Collegio esterno, composto da persone diverse. Il ricorso è ammesso per:

   a) vizio procedurale;

   b) manifesta irragionevolezza tecnica;

c) discriminazione;

d) manifesta sproporzione.

Si applicano il Codice 4, articolo 17, e il Codice 5, articolo 9. Il Collegio di secondo grado non può aggravare la posizione del ricorrente.

9. Durante la procedura di accertamento dell'inidoneità definitiva, la persona conserva il Paniere di Sufficienza e riceve una proposta di CBO alternativo compatibile.

10. Nessun dato sanitario può essere usato per limitare l'accesso alle deliberazioni, al Paniere o all'apprendimento.

CAPO II — CURA, FRAGILITÀ E SALUTE MENTALE

Art. 6 — Cura primaria e Magazzino Salute

1. Ogni Magazzino dispone di un Magazzino Salute e di un Paniere Salute minimo, definiti dal Consiglio Salute federato secondo le competenze dei Codici. Il Paniere comprende almeno:

   a) farmaci essenziali salvavita;

   b) materiale di primo soccorso;

   c) DPI di competenza sanitaria;

   d) strumenti diagnostici di base;

   e) documentazione e STV sanitarie validate.

2. La cura primaria è organizzata mediante affiancamento e ambulatori di Cerchio, con il coinvolgimento di competenze L2 e L3. La persona sceglie tra le competenze disponibili, anche appartenenti ad altri Cerchi.

3. L'IA prevista dal Codice 7 può supportare l'indicizzazione dei protocolli, la ricerca di informazioni e i promemoria. Non può formulare autonomamente diagnosi, determinare l'idoneità o decidere il trattamento.

4. Quando una competenza non è disponibile localmente, il Consiglio Salute attiva la rete tra Cerchi e il Registro Dipendenze previsto dal Codice 15. Le misure possibili comprendono:

   a) l'invio della persona al servizio competente;

   b) l'invio temporaneo della competenza al Cerchio interessato;

   c) il tele-affiancamento supervisionato da una persona L3, quando appropriato e sicuro.

5. La modalità scelta rispetta la volontà della persona, la riservatezza sanitaria e la continuità della cura.

6. La tutela della salute si articola nei tre livelli integrati dell'articolo 28.1 della Costituzione: l'IA personale offline con funzione preventiva, secondo l'articolo 5-bis del Codice 7; i curanti della Comunità di Base; i centri di alta specializzazione del Cerchio 3.

Art. 7 — Fragilità, interdipendenza e cura

1. Anziani, bambini, persone con disabilità, persone con malattie croniche, persone in gravidanza o nel periodo successivo al parto, persone in lutto o in situazione di crisi hanno diritto a una tutela rafforzata e, quando necessario, alla modulazione del CBO ai sensi dell'articolo 11 del Codice 1 e del Codice 12.

2. La cura delle persone fragili rientra nel CBO di Lista A ed è collocata al livello 4 della gerarchia di priorità dell'articolo 32 del Codice 1.

3. Le attività di cura non possono essere differite per carenza logistica, salvo che debbano essere gestite emergenze vitali di livello 1 o 2. La decisione di differimento è motivata e deve prevedere, ove possibile, una misura sostitutiva.

4. Ogni Piano CBO include una quota di cura e affiancamento. La cura non è considerata un'attività

residuale da svolgere solo dopo aver soddisfatto gli altri fabbisogni.

5. La modulazione del CBO non comporta riduzione del Paniere di Sufficienza né annotazioni pregiudizievoli.

Art. 8 — Salute mentale e protocollo per la crisi acuta

1. La salute mentale è parte integrante della salute. Distress, burnout, conflitto e trauma non costituiscono colpa o debolezza individuale.
2. Il Consiglio Salute garantisce, direttamente o mediante il coordinamento con il Codice 12:
   a) spazi di ascolto;
   b) gruppi di parola;
   c) affiancamento psicologico L2 o L3;
   d) riduzione temporanea del carico CBO, quando necessaria;
   e) supporto tra pari;
   f) accesso a competenze specialistiche senza lista d'attesa interna ingiustificata.
3. In caso di crisi acuta si applica, come regola, un protocollo di protezione non coercitivo, basato su:
   a) presenza e ascolto;
   b) messa in sicurezza relazionale e ambientale;
   c) proposta di supporto;
   d) coinvolgimento, se desiderato dalla persona, di una persona di fiducia da lei designata.
4. Una misura coercitiva immediata è ammessa solo se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
   a) esiste un rischio vitale immediato e concreto per la persona o per terzi, documentato al momento da due persone con competenza L3, almeno una delle quali sanitaria;
   b) la persona è temporaneamente incapace di esprimere un consenso valido;
   c) non esiste, nell'immediato, una misura meno invasiva ugualmente efficace.
5. Ove le due competenze L3 non siano immediatamente disponibili, sono attivate senza ritardo le procedure di reperimento federato o di tele-affiancamento previste dall'articolo 13 del Codice 15. Nell'attesa sono ammesse esclusivamente misure non coercitive necessarie alla messa in sicurezza immediata.
6. L'intervento coercitivo eventualmente adottato:
   a) è limitato al tempo strettamente necessario a scongiurare il rischio vitale;
   b) è effettuato con presenza di due persone L3, quando immediatamente disponibili;
   c) è comunicato senza ritardo al Cerchio di Garanzia;
   d) è documentato in Rete con accesso regolato;
   e) è comunicato alla persona di fiducia designata, quando possibile;
   f) cessa immediatamente quando vengono meno i presupposti.
7. Entro ventiquattro ore il Cerchio di Garanzia verifica la legittimità procedurale, la necessità e la proporzionalità della misura. Non svolge una valutazione clinica, che resta di competenza delle persone sanitarie L3.
8. Dopo la crisi è proposto alla persona un percorso di cura volontario.
9. Sono sempre vietati la contenzione punitiva, l'isolamento usato come sanzione e la sedazione punitiva.
10. Qualsiasi misura coercitiva che superi ventiquattro ore richiede una nuova deliberazione dell'Assemblea secondo il Codice 3, il coordinamento con il Codice 14 e un riesame del Cerchio di Garanzia. La deliberazione non può derogare ai diritti fondamentali né prolungare una misura dopo la cessazione dei suoi presupposti.
11. È vietato inserire etichette stigmatizzanti nel Portfolio Personale.

Art. 8-bis — Testamento biologico e fine vita

1. Il testamento biologico è vincolante, ai sensi dell'articolo 27.3 della Costituzione. È redatto dalla persona, con l'eventuale assistenza della propria IA personale offline e alla presenza di due testimoni; è custodito nel Nodo personale e, se la persona lo desidera, presso il Consiglio Salute in forma riservata. È revocabile e modificabile in ogni momento.
2. Con il testamento biologico la persona può designare il proprio rappresentante per il caso di incapacità, ai sensi dell'articolo 7-bis del Codice 12.
3. Nessuno può essere sottoposto contro la propria volontà ad accanimento terapeutico. Le cure palliative e il sollievo dal dolore fanno parte del Paniere Salute.
4. È garantito il diritto al domicilio, con il supporto comunitario a turni previsto dal Codice 12. Le Case Comuni autogestite sono una scelta della persona e non possono costituire una destinazione coatta.

CAPO III — INFORTUNI, FARMACI, RISERVATEZZA E AUTONOMIA

Art. 9 — Infortuni, quasi-infortuni e malattie professionali

1. Ogni infortunio, quasi-infortunio o sospetta malattia professionale è segnalato e registrato senza ritardo. Il registro operativo contiene solo le informazioni necessarie all'analisi dell'evento, tra cui:
   a) descrizione dell'accaduto;
   b) mansione svolta;
   c) Scheda di Sicurezza applicabile;
   d) DPI e protezioni disponibili;
   e) condizioni operative pertinenti;
   f) data e ora dell'evento.
2. I dati identificativi e sanitari sono conservati separatamente e con accesso riservato secondo gli articoli 7 del Codice 14 e 11 del presente Codice. Le informazioni pubblicate sono aggregate e anonimizzate.
3. L'analisi distingue, senza presumere automaticamente una responsabilità individuale:
   a) usura o caso fortuito, che comportano la revisione delle STV e dell'organizzazione, senza responsabilità individuale automatica;
   b) carenze organizzative, che richiedono la revisione delle misure da parte del Cerchio responsabile e del Consiglio Salute;
   c) condotte dolose o altre condotte individuali rilevanti, che sono trattate secondo il Codice 4.
4. La persona infortunata ha diritto alla cura, al mantenimento del Paniere e, durante la convalescenza, alla proposta di un CBO alternativo adattato, quando compatibile con la sua condizione.
5. Il Consiglio Salute federato svolge almeno trimestralmente un'analisi aggregata degli infortuni e dei quasi-infortuni per proporre l'aggiornamento delle STV del Codice 2 e delle Schede di Sicurezza.
6. Il ciclo di prevenzione comprende: registrazione dell'evento, analisi delle cause, aggiornamento delle misure, revisione delle STV e prevenzione di eventi futuri.

Art. 10 — Paniere Salute, farmaci, fitoterapia e sperimentazione

1. Il Paniere Salute costituisce parte del Paniere di Sufficienza previsto dal Codice 1. Comprende beni salvavita la cui indisponibilità può determinare un'emergenza vitale di livello 1.
2. La Confederazione persegue l'autonomia nella produzione o nell'approvvigionamento federato di farmaci essenziali non brevettati e dispositivi riutilizzabili, secondo le STV del Codice 2. Le dipendenze critiche da fornitori esterni sono registrate nel Registro Dipendenze previsto dal Codice 15.

3. Per **fitoterapia validata** si intende un preparato vegetale corredato da una STV vigente che indichi almeno:

    a) la specie e la parte utilizzata;

    b) il dosaggio;

    c) le indicazioni e le controindicazioni;

    d) le interazioni note;

    e) le evidenze disponibili e i relativi limiti;

    f) le modalità di preparazione e conservazione.

L'uso tradizionale, da solo, non costituisce validazione. Ogni preparato validato è registrato nel Registro STV Salute.

4. È vietata la dipendenza proprietaria critica da cui dipendano farmaci salvavita, dispositivi diagnostici essenziali o DPI. Si applicano gli articoli 4 e 5 del Codice 2 e le disposizioni del Codice 15.

5. Nessuna sperimentazione sanitaria può essere svolta su membri senza consenso libero, informato, specifico e revocabile. Il consenso è documentato per iscritto dopo aver fornito informazioni comprensibili su rischi, benefici, alternative e diritto di recesso.

6. La sperimentazione richiede preventivamente:

    a) l'approvazione di un Collegio esterno sorteggiato secondo il Codice 4, articolo 17, composto da tre persone con competenza sanitaria L3 non coinvolte nella sperimentazione;

    b) il parere del Cerchio di Garanzia sul consenso e sulla proporzionalità;

    c) la deliberazione dell'Assemblea Generale secondo il Codice 3.

7. È vietata la sperimentazione su minori, persone in crisi acuta ai sensi dell'articolo 8 o persone temporaneamente prive della capacità di esprimere il consenso, salvo il caso eccezionale in cui sia diretta a conseguire un beneficio diretto e specifico per la persona stessa. In tale caso devono ricorrere cumulativamente tutte le condizioni seguenti:

    a) consenso del rappresentante designato secondo l'articolo 7-bis del Codice 12. La persona di fiducia non è considerata rappresentante, salvo che sia stata formalmente designata a tale funzione;

    b) se il rappresentante non è disponibile, applicazione della procedura urgente prevista dall'articolo 7-bis del Codice 12 per la persona temporaneamente incapace, inclusa la nomina urgente di un rappresentante da parte dell'organo competente;

    c) parere conforme scritto di due persone L3 indipendenti e non coinvolte, attestante il beneficio diretto, l'assenza di alternative di efficacia comparabile e la proporzionalità del rischio;

    d) autorizzazione del Cerchio di Garanzia sui profili di consenso e proporzionalità;

    e) deliberazione dell'Assemblea Generale secondo il Codice 3, con maggioranza qualificata e tracciamento delle posizioni espresse;

    f) ascolto e rispetto della volontà della persona nella misura in cui sia in grado di esprimerla.

La mancanza di una sola delle condizioni impedisce l'avvio della sperimentazione.

8. Ogni sperimentazione deve prevedere tracciamento, copertura delle responsabilità collettive, accesso alla cura per eventuali conseguenze e diritto di recesso immediato senza pregiudizio.

9. La violazione dei commi da 5 a 8 costituisce vizio procedurale grave e comporta l'applicazione del Codice 4, compresi gli effetti di invalidità e gli obblighi di riparazione.

Art. 11 — Riservatezza sanitaria e separazione dei dati

1. La persona cui il dato sanitario si riferisce ne mantiene il controllo. Il Sistema fiduciario del Cerchio svolge funzioni di custodia e gestione tecnica, senza poter utilizzare i dati per finalità proprie o incompatibili.

2. L'accesso ai dati sanitari è regolato come segue:

a) l’accesso ordinario spetta alla persona interessata e alla persona di fiducia da essa designata, nei limiti del consenso;

b) il Consiglio Salute può accedere alle informazioni necessarie alla sorveglianza sanitaria, limitandosi, di norma, ai giudizi di idoneità e agli adattamenti e non alle diagnosi dettagliate;

c) il Cerchio di Garanzia può accedere ai dati necessari per decidere un ricorso, secondo una procedura tracciata e con accesso limitato;

d) in assenza di consenso, l’accesso del Consiglio Salute è ammesso solo quando sia necessario a dare esecuzione a un obbligo di sicurezza collettiva validamente deliberato ai sensi dell’articolo 2-bis. L’accesso è limitato ai dati strettamente necessari, proporzionato e temporaneo, è tracciato e, quando possibile, comunicato alla persona interessata. È ammesso il riesame del Cerchio di Garanzia entro sette giorni.

3. Il Magazzino del Sapere contiene esclusivamente:

a) Schede di Sicurezza prive di dati sanitari individuali;

b) STV sanitarie anonimizzate;

c) statistiche aggregate sugli infortuni;

d) protocolli di cura validati.

Non contiene dati sanitari individuali.

4. È vietata la pubblicazione di dati sanitari nominativi, elenchi di patologie riferibili a persone o mappe individuali di fragilità. La violazione costituisce vizio procedurale grave secondo il Codice 4.

5. Ogni persona ha diritto:

a) di ottenere copia dei propri dati sanitari;

b) di chiederne la rettifica;

c) di chiederne la cancellazione quando non siano più pertinenti o necessari;

d) di chiedere la cancellazione o l’oblio di episodi superati, salvo gli obblighi di sicurezza collettiva documentati e validamente deliberati ai sensi dell’articolo 2-bis, limitatamente alle informazioni strettamente necessarie.

6. La cancellazione o rettifica del dato personale non comporta la cancellazione di informazioni già rese irreversibilmente anonime e utilizzate per statistiche, analisi epidemiologiche o aggiornamento delle STV. I dati personali sono tenuti distinti dai dati statistici anonimi e non devono poter essere ricostruiti.

Art. 12 — Disposizioni transitorie e collegamenti

1. Il presente Codice si coordina con:

a) Codice 1, articoli 27, 29, 31 e 32;

b) Codice 2, per le STV e la validazione dei beni;

c) Codice 3, per le procedure d’urgenza e le deliberazioni;

d) Codice 4, articolo 17, per il Collegio di Riesame e le garanzie;

e) Codice 5, per le competenze L2 e L3, l’articolo 4, comma 2, lettera c), l’articolo 4, comma 5, e l’articolo 10;

f) Codice 12, per la cura delle persone fragili;

g) Codice 14, per la sicurezza generale;

h) Codice 15, per il Registro Dipendenze.

2. Si applica la validazione provvisoria sanitaria prevista dall’articolo 10 del Codice 5. Chi esercita una funzione sanitaria ad alto rischio alla data di entrata in vigore può mantenere una validazione provvisoria:

a) per sei mesi per le funzioni corrispondenti al Livello 3 del Codice 5;

b) per dodici mesi per le funzioni corrispondenti al Livello 2 del Codice 5.

Sono richiesti l’iscrizione al percorso di validazione entro trenta giorni, la supervisione rafforzata, il rispetto delle STV e la tracciabilità delle attività. Durante il periodo provvisorio la persona non può validare le competenze di altri.

3. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1 attiva un Magazzino Salute minimo e predispone le Schede di Sicurezza per le mansioni sanitarie e di sicurezza sanitaria classificate L3 e attive, secondo il Codice 5, articolo 4, comma 2, lettera c).
4. Per le mansioni L3 non sanitarie si applicano il Codice 5 e il Codice 14; il presente Codice non ne disciplina la validazione tecnica.
5. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore è svolto un audit federato sull’autonomia farmaceutica e sui DPI, con registrazione delle dipendenze critiche nel Registro Dipendenze del Codice 15.